

УДК :618.19-006.6.771

¹Н.Т. Балтабеков, ²М. Чезаре, А.А. Шортанбаев, ³А.К.Туманова, ³Ш.Ж. Талаева, ³А.Я. Тогузбаева,
³Р.З.Абдрахманов, Ш.Т. Пазылов, А. Бакасова

¹Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Асфендиярова,

²Университетская больница г. Брешиа, Италия,

³Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии,

⁴Алматинский Онко Центр.

Медицинская реабилитация в онкологии. Профилактика гематологических и иммунологических осложнений с использованием надерина при первой линии химиотерапии рака молочной железы. Грант КазНМУ 2013.

Аннотация: Работа посвящена медицинской реабилитации и профилактике гематологических и кардиологических осложнений химиотерапии по схеме АС при раке молочной железы с использованием нуклеонате натрия – надерина. При этом использованием Надерина позволяет достоверно снизить количество гематологических осложнений в виде лейкопении с 39.02% до 14.7% ($p < 0.001$). Отмечено значительное повышение качества жизни больных в основной группе, получавших надерин при химиотерапии РМЖ по сравнению с контрольной группой, что позволило всем 38 пациентам без перерыва закончить полностью 4 курса химиотерапии. В контрольной группе у 16 из 41 пациенток была остановка химиотерапии и потребовалось введение колониостимулирующих факторов и летальность после химиотерапии в контрольной группе составила 2.43%.

Ключевые слова: химиотерапия, осложнения, лейкопения, надерин, реабилитация.

Актуальность. Злокачественные новообразования, относятся к социально значимым заболеваниям в связи с высоким уровнем инвалидизации и смертности.

Рак молочной железы (РМЖ) – самое частое онкологическое заболевание у женщин. Ежегодно в мире регистрируется свыше 1 млн 150 тысяч новых случаев данных опухолей и около 500 тысяч женщин погибает от этого заболевания [1].

В Республике Казахстан рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости. Так, в 2014 году выявлено 4142 новых случая данной патологии, а темп прироста является одним из самых высоких среди всех злокачественных новообразований и составляет 5.6% [2].

К осложнениям, возникающим в процессе химиотерапевтического лечения данной группы пациентов относятся лейкопения, тромбоцитопения и вторичный клеточный иммунодефицит, кардио- и гепатотоксичность [1].

Наличие данных осложнений является причиной резкого ухудшения качества жизни больных, остановки лечения, приводит к

прогрессированию основного заболевания и значительно ухудшает прогноз [3].

Так в 2014 году по данным КазНИИ Онкологии в Казахстане из 2953 женщин закончивших лечение по поводу рака молочной железы более половины – 56.1%, получали противоопухолевую химиотерапию в течении 4-6 месяцев. Наиболее частым вариантом первой линии химиотерапии у более 60% пациенток при раке молочной железы была схема «АС»- дакарбазин 60 мг на квадратный метр в 1 день и циклофосфан 600мг на квадратный метр в среднем 4 курса с интервалом 21 день [2].



Рисунок 1 – Схема осложнений химиотерапии

При угнетении клеток иммунной системы происходят следующие инфекционные осложнения: бактериальные, вирусные, грибковые инфекции и дисбактериоз. Инфекционные осложнения, в следствии снижения уровня иммунитета – лейкопении, нейтропении являются одной из основных причин смерти онкобольных при химиотерапии, ухудшают качество жизни.

Иммунокорригирующая терапия включает:

1. Цитокины (гемопозитические факторы роста или колониестимулирующие факторы – КСФ);
2. Гормональные препараты (глюкокортикостероиды)
3. Иммуномодуляторы (деринат, тималин, надерин);
4. Заместительная терапия – механическое переливание лейкоцитарной массы.

В поле зрения ученых-медиков Казахстана попал иммуномодулирующий препарат на базе DNA-Na (деринат натрия), «Naderyn» производства Италии. При апробации которого в совместных пилотных Италияно – Казахстанских исследованиях 2007-2010 годов в клиниках Университетской многопрофильной больницы г. Брешиа, регион Ламброджия, Италия (М. Чезаре, А. Феррари), и Городского Онкологического Диспансера г. Алматы, Казахстан, были получены обнадеживающие результаты использования надерина для профилактики лейкопении, инфекционных осложнений при лекарственной противоопухолевой терапии рака молочной железы, меланоме кожи, рака почки и колоректальном раке. (Н.Т. Балтабеков, Д.Р. Кайдарова, Г.Г. Люмузова, Ш.Т. Пазылов, 2010г.)

Полученные предварительные результаты Италияно -Казахстанско пилотного проекта послужила поводом для проведения многоцентрового рандомизированного исследования Казахского Национального Медицинского Университета им. С.Асфендиярова –Грант КазНМУ 2013-«Новые подходы к иммунорегирующей терапии с использованием надерина при базисной терапии социально значимых заболеваний, включая туберкулез, злокачественные новообразования и гепатит С». В этой статье приводится фрагмент данного исследования.

Цель исследования – Снижение осложнений при химиотерапии рака молочной железы.

Задачи исследования:

1. Изучить процент гематологических, кардиологических и иммунологических осложнений при адъювантной полихимиотерапии рака молочной железы по схеме «АС» при II В и III стадии опухолевого процесса.
2. Оценить при использовании «надерина» в качестве «средства медицинской реабилитации» частоту гематологических, кардиологических и иммунологических осложнений при адъювантной полихимиотерапии рака молочной железы по схеме «АС» при II В и III стадии опухолевого процесса.
3. Сравнить полученные результаты в двух группах и оценить эффективность медицинской реабилитации с использованием надерина при химиотерапии рака молочной железы.

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужили данные 79 больных с гистологически верифицированным раком молочной железы II В и III стадии, получавших неоадъювантную химиотерапию по схеме «АС», в условиях маммологического отделения КазНИИ Онкологии и Радиологии с июня 2014 по октябрь 2015 года -25 больных, а так же с марта 2014 по ноябрь 2016 года в дневных стационарах химиотерапии Алматинского Онкологического Центра -20 пациенток и КазНИИ онкологии и радиологии -34.

В зависимости от метода исследования путем рандомизации больные были разделены на 2 группы :

- **В первую** группу вошли 38 пациентов с диагнозом рак молочной железы, получавших 4 курса адъювантной полихимиотерапии по схеме АС дакарбазин 60 мг на квадратный

метр в 1 день и циклофосфан 600мг на квадратный метр -4 курса с интервалом 21 день.

в сочетании с приемом нуклеоната натрия – «надерином» по 2 драже ежедневно в течении 4 месяцев.

- **Во вторую**, контрольную группу включили 41 больных с диагнозом –рак молочной железы получавших только 4 курса адъювантной полихимиотерапии по схеме АС.

Всем пациентам проводился контроль общего анализа крови до и после каждого курса полихимиотерапии, определение иммунного статуса (ИРИ) CD4/CD8 перед началом первого курса и после окончания 4 курса, Эхокардиография до начала и после окончания 4 курсов, биохимический анализ крови перед началом первого курса и после окончания 4 курса.

Результаты исследования. Анализ полученных данных в основной группе пациенток, получавших при схеме АС надерин выявил, что все 38 пациенток закончили все 4 курса химиотерапии, не запланированных перерывов не было, инфекционных осложнений не отмечено, летальных случаев не выявлено, при этом:

- частота лейкопении составляла 14.5%, максимальное снижение лейкоцитов отмечалось до 3.5 на 10 в девятой степени;
- кардиологические осложнения не были выявлены в 6%, а у 5 пациенток (13%) отмечено повышение систолического выброса от 9 до 18%;
- снижение иммунорегуляторного индекса выявлено у 32%, снижение ИРИ на 21,3% от исходного и средний показатель ИРИ составил 1.05.

В контрольной группе среди женщин получавших только химиотерапию по схеме АС при раке молочной железы были выявлено, что из 41 пациенток после 3 курса химиотерапии у 16 больных отмечено значительное снижение лейкоцитов, что потребовало введения колониостимулирующих факторов. При этом одна пациентка 46 лет с диагнозом рак молочной железы II В стадии, состояние после радикальной мастэктомии и 4 курсов ПХТ по схеме АС погибла на дому на фоне инфекционных осложнений на 11 сутки после окончания 4 курса химиотерапии.

При этом в контрольной группе было выявлено:

- частота лейкопении составляла 39.02% максимальное снижение лейкоцитов отмечалось до 0.5 на 10 в девятой степени;
- кардиологические осложнения были выявлены у 25,1% пациенток и отмечено снижение систолического выброса в среднем на 14.7%, нарушение ритма в виде тахикардии 29,5%, экстрасистол 31,2%;
- снижение иммунорегуляторного индекса выявлено у 93%, на 61% от исходного и средний показатель ИРИ составил 0.7.

ВЫВОДЫ.

1. Медицинская реабилитация при первой линии химиотерапии рака молочной железы по схеме АС с использованием нуклеоната натрия –Надерина позволяет достоверно снизить количество гематологических осложнений в виде лейкопении с 39.02% до 14.7% ($p<0.001$).
2. Использование надерина по данным эхокардиологического исследования снижает количество кардиологических осложнений антрациклидов при первой линии химиотерапии по схеме АС у пациенток с диагнозом рак молочной железы с 25.1% до 6,0% ($p<0.001$).
3. Применение нуклеоната натрия –надерина в целях медицинской реабилитации при химиотерапии рака молочной железы по схеме АС снижает процент иммунодепрессии с 93% до 32% ($p<0.001$).
4. Отмечено значительное повышение качества жизни больных в основной группе, получавших надерин при химиотерапии РМЖ по сравнению с контрольной группой, что позволило всем 38 пациентам без перерыва закончить полностью все 4 курса химиотерапии. В контрольной группе у 16 из 41 пациенток была остановка химиотерапии и потребовалось введение колониостимулирующих факторов и летальность после химиотерапии в контрольной группе составила 2.43%.
5. Профилактическое использование надерина при химиотерапии рака молочной железы позволило уменьшить риск летальных осложнений после химиотерапии антрациклидами и является перспективным направлением в повышении качества медицинских услуг в сфере медицинской реабилитации онкологических больных.

Список литературы

1. Абисатов Х.А. // Клиническая онкология.- Алматы: Арыс, 2007. – Т.2- С. 35-72.
2. Нургазиев К.Ш., Байпеисов Д.М., Аuezова Э.Т. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2014 году, статистические материалы.-Алматы, 2015.
3. Балтабеков Н.Т. Шортанбаев А.А., Туманова А.К. Новые подходы к иммунотерапии с использованием надерина при социально значимых заболеваниях, включая рак молочной железы, туберкулез, гепатит С. Грант КазНМУ -2013 // Онкология и радиология Казахстана.-2013.- №4 (30). – С19-20.
4. Baltabekov N. T., Shortanbayev A.A., Rakisheva A.S., Tumanova A.K. Immunological aspects of medical rehabilitation in oncology, phthisiology and hepatology. Grant KAZNMU 2013. Republic Kazakhstan.G. Almaty. Chair of internship and residency in oncology. The Kazakh National Medical University (КазНМУ) of S. Asfendiyarov.

ТҰЖЫРЫМ

Н.Т.Балтабеков¹, М.Чезаре², А.А.Шортанбаев, А.К.Туманова³, Ш.Ж.Талаева³, А.Я.Тогузбаева³, Р.З.Абдрахманов³, Ш.Т.Пазылов, А.Бакасова

¹С.Д. Асфендияров атындағы Қазақтың Ұлттық медицина университеті,

²Университетінің ауруханасы Брешия қ., Италия,

³Қазақ онкология және и радиологии ғылыми-зерттеу институті,

4Алматылық Онкоцентр

Онкологиядағы медициналық реабилитация. Сүт безі қатерлі ісігіндегі гематологиялық және иммунологиялық асқынуларға химиотерапияның алғашқы кезегінде надеринді қолдану

Грант КазҰМУ 2013

Жұмыс сүт безі рагының надерин атты нуклеонат натриді қолданумен АС схемасынан кейінгі химиотерапиялық асқынулардағы гематологиялық және кардиологиялық профилактика мен медициналық реабилитацияға арналған. Сонымен қоса сүт безі рагының АС схемасы бойынша бірінші қатардағы химиотерапияда надерин атты нуклеонат натриді қолдану лейкопения түріндегі 39,02%-дан 14,7%-ға дейін ($p<0.001$) гематологиялық асқынулар көлемін азайтатыны мәлім. Басты топтағы зерттелуші науқастарды зерттелуші топпен салыстырғанда сүт безі рагының химиотерапиясына надеринді қосқанда науқастардың өмір сүру сапасының артуы анықталды, нәтижесінде барлық 38 науқасқа 4 курс химиотерапияны толық алуға мүмкіндік берді. Бақылаушы топта 41 науқастың 16-сы химиотерапиядан кейін колонобелсендіргіш факторларды көк тамыр ішіне енгізуді талап етті, ал өлім көрсеткіші бақылау тобында 2,43% құрады.

Түйінді сөздер: химиотерапия, лейкопения, надерин, реабилитация.